Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno (a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Alvaro Mateo Parás López				Sexo	F	M ✓
Fecha Nacimiento	06·09·2018	Edad actual	6 años	meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Portal Jurcal Psj. Alto los Ronces #2017			Teléfono	9-89032934 Mamá		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☐				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☐				
Escolaridad actual:	1° A.	Establecimiento	Liceo Mixto Los Andes Básico N°1				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 03·04·2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Daniela Antonia López A.	Nombre:
Relación con el/la estudiante: madre.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 03·04·2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Yesenia Jara Valero.	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Dificultan en lenguaje.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Si (especificar)

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Fecha/Hora: 22-05-2025 9:18
Fecha Cierre: 22-05-2025

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: Tª Expresivo.	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) | Peso: | Talla:

¿Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Embarazo de termino programado, sin dificultades.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	~~Sí~~	No	Enfermedad respiratoria	~~Sí~~	No	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	X No			
Hospitalizaciones	Sí	~~No~~	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	Sí	No	Vacunas	Sí	No

Observaciones:

Toma coticoides, aun no se descarta asma.
Presenta rinitis alergica, toma medicación todo el año.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: –	Se sienta sólo/a: –	Camina sin apoyo: –
Primeras palabras: 12 M.	Primeras frases: –	Se viste solo/a: 3 Años

Controla esfinter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓ 3 Años	Controla esfinter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓ 3 Años

Observaciones:

Madre indica que presentó retraso en el desarrollo.

En su actividad motora general se aprecia: ☐ normal ☒ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** ☐ normal ☐ hipertónico ☒ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	Sí	~~No~~	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	Sí	~~No~~	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	Sí	~~No~~
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	~~No~~

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Observaciones:
Sin antecedentes.

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:
Cuando escucha ruidos fuertes y agudos cubre sus oídos.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones:
Sin antecedentes.

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico (repite palabras, sílabas, etc.)	Sí	No	Movimientos estereotipados (repetitivos)	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces: ☑ natural ☐ desmesurada

Sonidos: ☐ natural ☑ desmesurada

Personas extrañas: ☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones:
Solo cuando los ruidos son fuertes.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Alimentación: ☐ normal ☒ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme:

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☑ acompañado (Especifique): madre - Papa

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☑ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:
Es conversador, alegre.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Pamela López	Madre	27	En. Sup.	garzona Enjoy
2. Felipe Parás	Padre	37	En. Sup.	Chef.
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO

Antecedentes de S
(Señale aquellos ante
Por parte
Por parte

Observaciones:
Enferme

7. ANTECEDE
Trayectoria esc
Edad de ingreso
N° de colegios e
Motivo de los ca
Escuela
Ha repetido cur
Situación actu
Nivel/curso actual
Asiste regularmente
Actitud de la
¿Cómo evalú
☑ satisfactorio
¿Cuál es la r
☑ apoyo ☐ c
¿Cuál es la r
☑ apoyo ☐
Especifique e
☑ expresione
¿Quiénes ap
☑ madre ☑
¿Qué expec
☑ alta (inclu
¿Ofrece la f
☐ Ambos ☑

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
*(Señale aquellos **antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere** el o la estudiante):* Por parte de mamá - Diabetes (abuelos) Por parte de Padre - Cáncer (abuelos - tías).
Observaciones: Enfermedades en control médico.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar			
Edad de ingreso al sistema escolar	3	Asistió a jardín infantil	☒ Sí ☐ No
N° de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☒ Especial ☐ Técnica ☐:	
Motivo de los cambios: Escuela de Lenguaje Voces del Valle.			
Ha repetido curso/s	☐ Sí ☒ No	Curso(s)	Motivo: No Aplica.

Situación actual											
Nivel/curso actual	1° A.		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	☒ No	**Dificultad para participar**	Sí	☒ No	**Conducta disruptiva**	Sí	☒ No
Asiste regularmente	☒ Sí	☐ No	**Asiste con agrado**	Sí	☒ No	**Apoyo familiar en tareas**	☒ Sí	☐ No	**Amigos (as)**	☒ Sí	☐ No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☒ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra Repasar Materias.....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☒ expresiones afectivas ☒ alimentos preferidos ☐ ver TV ☒ juguetes ☒ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☒ madre ☒ padre ☐ hermanos/as ☒ Otros familiares ☐ Otros profesionales . abuela.....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☒ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☐ Ambos ☒ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☒ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

5

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY